テスト用架空事例

認定結果(テスト用設定)

要介護度	要介護2
認定日	令和8年8月26日(テスト用)
認定の有効期間	令和8年7月22日～令和9年1月31日(新規・6か月)(テスト用)

認 定 調 査 票 (概 況 調 査)

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年8月5日 (テスト用)
実施場所	入院先の病院(回復期リハビリテーション病棟)
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	新規申請		
対象者氏名	大野 千代 (おおの ちよ)	性別	女
生年月日	昭和16年(1941年)2月11日	年齢	85歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

なし(入院中。令和8年8月末に退院予定。退院後に通所リハビリテーション、福祉用具貸与の利用を予定)。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	長男夫婦(長男58歳・妻56歳)と同居。長男夫婦は共働きで、平日の日中(8時～18時)は一人になる。孫は独立。
居住環境	築40年の木造2階建て持ち家。本人の部屋は1階の和室(布団)。トイレまで約8m、廊下に段差(約3cm)あり。浴室に手すりなし。
使用している機器等	病棟内では歩行器を使用。
生活歴	和菓子店の家に生まれ、結婚後も夫と店を続けた。夫は10年前に死去。近所の友人との茶話会が楽しみ。
本人・家族の主訴	本人:「早く家に帰りたい。また転ぶのは怖い。」 長男:「日中は誰もいないので、一人のときに転ばないか心配。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	(ない) 左上肢　右上肢　左下肢　右下肢　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	ない　肩関節　(股関節)　膝関節　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-4 起き上がり	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-5 座位保持	(できる)　自分の手で支えればできる　支えてもらえればできる　できない
1-6 両足での立位保持	支えなしでできる　(何か支えがあればできる)　できない
1-7 歩行	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-8 立ち上がり	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-9 片足での立位	支えなしでできる　何か支えがあればできる　(できない)
1-10 洗身	介助されていない　(一部介助)　全介助　行っていない
1-11 つめ切り	介助されていない　(一部介助)　全介助
1-12 視力	(普通(日常生活に支障がない))　約1m離れた視力確認表の図が見える 目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない 見えているのか判断不能
1-13 聴力	(普通)　普通の声がやっと聞き取れる　かなり大きな声なら何とか聞き取れる ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	介助されていない　(見守り等)　一部介助　全介助
2-2 移動	介助されていない　(見守り等)　一部介助　全介助
2-3 えん下	(できる)　見守り等　できない
2-4 食事摂取	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-5 排尿	介助されていない　(見守り等)　一部介助　全介助
2-6 排便	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-7 口腔清潔	(介助されていない)　一部介助　全介助
2-8 洗顔	(介助されていない)　一部介助　全介助
2-9 整髪	(介助されていない)　一部介助　全介助
2-10 上衣の着脱	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-11 ズボン等の着脱	介助されていない　見守り等　(一部介助)　全介助
2-12 外出頻度	週1回以上　月1回以上　(月1回未満)
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	(調査対象者が意思を他者に伝達できる)　ときどき伝達できる ほとんど伝達できない　できない
3-2 毎日の日課を理解	(できる)　できない
3-3 生年月日や年齢を言う	(できる)　できない
3-4 短期記憶	できる　(できない)
3-5 自分の名前を言う	(できる)　できない
3-6 今の季節を理解する	(できる)　できない
3-7 場所の理解	(できる)　できない
3-8 徘徊	(ない)　ときどきある　ある

3-9 外出すると戻れない	(ない) ときどきある ある　テスト用架空事例
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	(ない) ときどきある ある
4-2 作話	(ない) ときどきある ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	(ない) ときどきある ある
4-4 昼夜の逆転がある	(ない) ときどきある ある
4-5 しつこく同じ話をする	(ない) ときどきある ある
4-6 大声をだす	(ない) ときどきある ある
4-7 介護に抵抗する	(ない) ときどきある ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	(ない) ときどきある ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない) ときどきある ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない) ときどきある ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない) ときどきある ある
4-12 ひどい物忘れ	ない (ときどきある) ある
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない) ときどきある ある
4-14 自分勝手に行動する	(ない) ときどきある ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	(ない) ときどきある ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	介助されていない (一部介助) 全介助
5-2 金銭の管理	介助されていない (一部介助) 全介助
5-3 日常の意思決定	できる(特別な場合でもできる) (特別な場合を除いてできる) 日常的に困難 できない
5-4 集団への不適応	(ない) ときどきある ある
5-5 買い物	介助されていない 見守り等 一部介助 (全介助)
5-6 簡単な調理	介助されていない 見守り等 一部介助 (全介助)

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理 □中心静脈栄養 □透析 □ストーマ(人工肛門)の処置 □酸素療法 □レスピレーター(人工呼吸器)
□気管切開の処置 □疼痛の看護 □経管栄養 □モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) □じょくそうの処置
□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立 J1 J2 A1 (A2) B1 B2 C1 C2
認知症高齢者の日常生活自立度	自立 Ⅰ (Ⅱa) Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

認定調査票(特記事項)

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	1-2 左股関節の曲げ伸ばしに制限がある(術後)。 1-3・1-4・1-8 ベッド柵や手すりにつかまって行う。 1-6・1-7 立位と歩行は歩行器を使う。病棟内は歩行器で見守り歩行。 1-10 シャワー浴で、背中と足を看護師が洗っている。 1-11 足の爪は看護師が切っている。
第2群 生活機能	2-1・2-2 ベッドから歩行器への乗り移りと病棟内の移動は、看護師が見守っている。 2-5 夜間はトイレまで看護師が付き添う。 2-11 左足にズボンを通すのを手伝ってもらう。 2-12 入院中のため外出していない。
第3群 認知機能	3-4 調査の直前に何をしていたか答えられなかった。入院してから物忘れが増えたと長男が話す。
第4群 精神・行動障害	4-12 リハビリの時間や、面会の予定を忘れることがある。
第5群 社会生活への適応	5-1 入院中は看護師が配薬している。入院前も飲み忘れがあり、長男の妻が確認していた。 5-2 入院前から、お金の管理は長男が手伝っている。 退院後は、日中一人の時間の転倒予防と、服薬の管理が課題になる。
特別な医療	該当なし。

主 治 医 意 見 書

テスト用架空事例

申請者	大野 千代 (女・85歳) 医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. 左大腿骨頸部骨折(人工骨頭置換術後)	令和8年6月20日
2. 骨粗しょう症	約10年前
3. 軽度の認知機能低下	令和8年7月
(2)症状としての安定性	安定
(3)経過及び治療内容	令和8年6月20日、自宅の廊下で転倒し左大腿骨頸部骨折。6月22日に人工骨頭置換術を受け、7月10日から回復期リハビリテーション病棟でリハビリ中。歩行器歩行が見守りで可能となり、8月末に自宅退院の予定。入院後、物忘れが目立つ(HDS-R 20点)。 投薬:骨粗しょう症治療薬(週1回)、活性型ビタミンD、鎮痛薬(頓用)。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

なし

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):A2 認知症高齢者の日常生活自立度:Ⅱa
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題あり/日常の意思決定:いくらか困難/意思の伝達:伝えられる
(3)認知症の行動・心理症状	なし
(4)その他の精神・神経症状	なし
(5)身体の状態	利き腕:右/身長146cm・体重42kg/左股関節の可動域制限/下肢筋力の低下/麻痺なし/褥瘡なし

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:していない(入院中)/車いす:病棟外の移動で介助者が操作/歩行補助具:屋内で使用(歩行器)
(2)栄養・食生活	食事行為:自立/栄養状態:やや不良/留意点:たんぱく質・カルシウムの摂取
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	再転倒・反対側の骨折、廃用による筋力低下、日中独居時の事故 → 住環境の整備(手すり・段差解消)、通所リハビリ、緊急時の連絡手段
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できる
(5)医学的管理の必要性	通所リハビリテーション
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	移動:転倒に注意/運動:人工骨頭の脱臼に注意(股関節の深い屈曲・内旋を避ける)
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

退院後は日中独居となるため、転倒予防のための住環境の整備と、通所リハビリによる歩行機能の維持が必要。服薬は家族の確認が必要。